

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	失禁性皮膚炎的照護 Incontinence-associated dermatitis of care				
編號	A31000-Q03-W-H01	制定者	MI 賴美玉	公布日期	109 年 07 月 21 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.3 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解失禁性皮膚炎的定義、危險因子、評估方式、處置與預防、護理問題與護理措施，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

「失禁」指個體無法自主控制排泄，包括排尿或解便，腹瀉定義為每天解水便或糊便達 4 次以上。失禁性皮膚炎(incontinence associated dermatitis, IAD)為潮濕相關皮膚損傷之一，指皮膚長時間暴露在尿液、糞便，導致肛門周圍、會陰部、臀部、大腿內側等部位皮膚出現浸潤、發紅、紅疹、水泡、表皮破損，造成炎症及疼痛等症狀，導致降低皮膚防護功能，進而誘發壓傷、細菌及黴菌感染。

（二）危險因子

大小便失禁、腹瀉、壓傷評估量表(Beaden scale)≤16 分、皮膚水腫、營養不良、皮膚濕度增加、皮膚老化、清潔方式不正確、知覺降低及活動障礙、藥物使用（包括：多種/長期抗生素、瀉劑、免疫抑制劑）等皆會造成失禁性皮膚炎。

（三）失禁性皮膚炎嚴重度分級

2015 年失禁性皮膚炎全球專案小組共識會議，為了更簡易辨識嚴重度，將失禁性皮膚炎嚴重度分級分為 0 級：皮膚完整且無發紅（但有發生 IAD 的風險）；一

主題名稱	失禁性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-H01	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	2/6

級：皮膚完整但有發紅情形；二級：皮膚破損合併有發紅情形，嚴重度分級越高，損傷程度越嚴重，若病人無失禁或腹瀉情形，則不屬於失禁性皮膚炎。

（四）失禁性皮膚炎照護及預防

1. 病人轉入單位時，進行皮膚評估，確認有無失禁性皮膚炎，拍照上傳至 HIS 系統，並填寫「壓傷及 IAD 評估」系統，依據病人狀況勾選：危險因子、發生原因、相關因素、嚴重程度分級、破損部位及大小，每日於 HIS 住院護理系統填寫評估表，評估病人失禁性皮膚炎病程變化。
2. 皮膚清潔：每次排泄後，使用中性或弱酸性皮膚清潔劑(PH=4-7)清潔，以棉質毛巾輕壓拭乾，避免用力擦拭或來回摩擦刷洗方式，勿使用肥皂，會使皮膚過於乾燥。
3. 防護隔離：主要隔絕皮膚受到排泄物的刺激，形成保護膜，依嚴重度分級選擇合適的皮膚防護品。0 級：長效保膚霜、無痛保護膜，皮膚乾燥處可使用含凡士林基底產品，皮膚潮濕處不建議使用。一級：皮膚發紅可選擇長效保膚霜、無痛保護膜，皮膚發紅且潮濕可選擇氧化鋅；二級：皮膚破損可使用無痛保護膜、含氧化鋅成分的保護膏。氧化鋅具有防腐及收斂的效果，可減少發紅及紅疹，每次清潔不需將氧化鋅完全移除，僅要將上層汙染去除後，再塗上新的一層氧化鋅即可。
4. 皮膚修復：當失禁性皮膚炎癒合後，仍需提供修復之潤膚產品，強化與維持皮膚屏障，如：含凡士林基底或保濕劑、含親脂性物質或油脂產品、含水凝膠隔離乳霜。
5. 合併有皮膚感染：依醫囑塗抹抗黴菌、抗生素、抗發炎及抗病毒藥膏於清潔後，使用皮膚防護品前。
6. 選擇透氣、吸水性高的丟棄式尿布，減少包覆多層尿布，避免悶熱及潮濕；採自然通風的方式，避免使用吹風機或烤燈，造成皮膚乾燥。
7. 每二小時檢查病人是否有排泄物，及早更換尿布，每次排泄後給予皮膚清潔及防護措施，未解便者，至少每六小時執行一次，可有效改善 IAD 嚴重度

表一、IAD 嚴重度分級與皮膚防護品的應用

主題名稱	失禁性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-H01	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	3/6

分級 方式	0 級	一級	二級
清潔	每次排泄後，使用免沖洗的液狀或泡沫狀皮膚清潔劑，PH=4-7（中性或弱酸性）清潔，再以棉質毛巾輕壓拭乾，避免用力擦拭或刷洗方式。	同左	同左
防護隔離		無痛保膚膜	1.無痛保膚膜 2.氧化鋅
修復	1.長效保膚霜。 2.含凡士林基底產品（潮濕處不建議使用）。	長效保膚霜	
合併表淺性 皮膚感染	1.抗黴菌、抗生素、抗發炎及抗病毒等外用藥膏使用於清潔後、皮膚防護品前。		
注意事項	1.肥皂、含鹼性、酒精添加物會使皮膚過度乾燥，不宜使用。 2.當皮膚潮濕時，不可使用以凡士林為基底的防護品。 3.若使用氧化鋅，每次清潔不需完全移除，僅要將上層汙染去除後，再塗上新的一層氧化鋅即可。		

（五）護理問題

1. 皮膚狀態不完整／大小便失禁有關。
2. 易感染／皮膚表皮受損有關。
3. 疼痛不適／組織創傷有關。

（六）護理措施

1. 皮膚狀態不完整／大小便失禁有關
 - (1) 清潔排泄物時，予中性或弱酸性清潔產品，並以棉質毛巾輕壓拭乾，避免用力擦拭或刷洗方式。
 - (2) 皮膚清潔後提供適合之隔離及修復之潤膚產品，強化與維持皮膚屏障。
 - (3) 當皮膚防護措施仍無法改善皮膚受損情形時，尿失禁使用尿套或置入導尿管，避免長期接觸刺激物。

主題名稱	失禁性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-H01	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	4/6

(4) 腹瀉時，依醫囑按時給予止瀉劑、益生菌使用，並與營養師討論更換適合的配方奶。

(5) 選擇透氣佳或吸水力佳的尿布，減少多層尿布包覆，每二小時確實檢查病人尿布是否有排泄物，及早更換尿布，採自然通風的方式，保持會陰部及肛門周圍清潔乾燥，避免使用吹風機或烤燈，造成皮膚乾燥。

(6) 每班確認皮膚狀況，評估紀錄傷口變化情形，每周至少一次拍照存檔，當皮膚狀況改變時需隨時拍照存檔，以利查核皮膚狀態的改變。

2. 易感染／皮膚表皮受損有關

(1) 監測生命徵象變化及全身性、局部性的感染徵象與症狀，當出現感染徵象時須立即告知醫師。

(2) 監測失禁性皮膚炎傷口變化，如：傷口大小、嚴重度等級、顏色、滲液及有無異味，傷口滲濕時予以換藥。

(3) 依醫囑以無菌技術換藥

(4) 當失禁性皮膚炎誘發細菌或黴菌感染時，會診皮膚科，依據細菌培養結果給予適當藥膏治療。

3. 疼痛不適／組織創傷有關

(1) 三班以疼痛評估數字量表，評估病人疼痛程度，記錄並觀察疼痛部位、性質、持續時間、疼痛加重及緩解因子。

(2) 依醫囑給予止痛劑，並評值藥物效果，適時與病人討論止痛劑使用時機。

(3) 教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想或予轉移注意力如：聽音樂、閱讀、聊天，以減輕疼痛。

(4) 至少每兩小時檢查尿布、協助翻身，並提供適當支托予以舒適臥位，減少排泄物對傷口反覆刺激。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	失禁性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-H01	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	5/6

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) Elsayed, S. M., & Elsharkawy, F. M. (2024). Effect of implementing a structured skincare protocol on the prevention of incontinence-associated dermatitis among critically ill patients. *Journal of Tissue Viability*. Advance online publication.
- (二) 林宜靜、陳映君、林淑緩、李玲玲(2022)・提升失禁性皮膚炎癒合率專案・安泰醫護雜誌，28(2)，13-29。
- (三) 鄭雅方、蘇郁婷、江慈慧、鄭碧芬、陳繪竹(2024)・運用跨團隊照護模式降低失禁性皮膚炎發生率之方案・高雄護理雜誌，41(1)，61-74。
- (四) Atlı, N., & Kahraman, B. B. (2025). Evidence-based nursing interventions in the prevention and management of incontinence-associated dermatitis: A systematic review. *Journal of Tissue Viability*, 34(3), 100924.

七、附件

(略)

主題名稱	失禁性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-H01	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
109.07.21	1.0	新制定。	109 年 07 月 08 日護理長會議通過;109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.10.07	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.1	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 第六項參考資料修訂。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	1.2	1. 第三項第四目之 1.修訂通報方式。 2. 第四項表單刪除。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	1.3	第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。